外科学血管和泌外疾病

考频（0-3题，★）：A_1 0-2　A_2 0-2　B 0-2　X 0-1

①周围血管疾病：动脉性疾病、静脉性疾病

②泌尿外科疾病：前列腺增生、肾结核、结石、肿瘤、外伤

核心精讲

周围血管疾病

性感认识：动脉VS静脉性疾病

一、动脉性疾病

外科　周围血管疾病&泌外感染和肿瘤
00:02:12--00:19:27

（一）雷诺综合征

①青壮年女性多见，多累及双侧手指（美甲）

抓规律：动脉和静脉性疾病很多积累于下肢（受重力影响），血管外科问题往往下肢多见

记特殊：雷诺综合征，双侧手指多见

②小动脉阵发痉挛→苍白发冷、青紫疼痛、潮红复原。动脉搏动正常、无杂音

③治疗：肾上腺素能神经末梢阻断剂如胍乙啶、利血平（瓜瓜一定摆平）。禁用普萘洛尔

「理顺知识点」

- 普萘洛尔（β-R 阻断剂）：阻断血管平滑肌β_2-R→加重平滑肌痉挛→雷诺综合征禁用

雷诺现象可见于：雷诺病、系统性硬化症、SLE（抗RNP抗体）、多发性骨髓瘤

（二）急性动脉栓塞

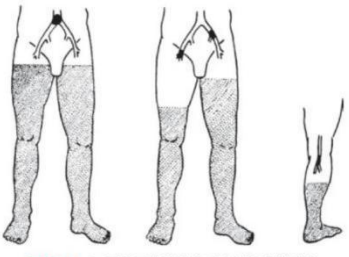


图 34-1　不同位置动脉栓塞后皮肤温度的改变
阴影代表皮肤温度降低区，都较实际栓塞部位低。

①左心来源的栓子最常见

②5P综合征：疼痛、麻痹、苍白、无脉、感觉异常（痛骂白无常）

③治疗：急诊Fogarty球囊导管取栓、或切开动脉直接取栓

若不耐受手术、坏死、远端小动脉栓塞、或栓塞时间长有侧枝→溶栓

（三）动脉硬化闭塞症 VS 血栓闭塞性脉管炎/Buerger病

1.共性

①表现：疼痛、麻木、苍白、寒冷、动脉搏动减弱消失

②治疗：经皮腔内血管成形术、旁路转流术，下垂患肢、保暖但不加热、抗板、抗凝、扩管等

③分期（一麻二跛三静四坏）

Ⅰ	仅麻木寒冷、动脉搏动减弱、踝/肱指数ABI＜0.9（酒干吗）
Ⅱ	间歇性跛行（Ⅱa＞200m/Ⅱb＜200m）、动脉搏动消失（Ⅱ-200）
Ⅲ	静息痛、夜间痛
Ⅳ	坏疽发黑、ABI＜0.4（Ⅳ-0.4）

「理顺知识点」

- 间歇性跛行：为运动性疼痛，常在步行中出现供血不足部位的沉重、乏力、胀痛或钝痛，或肢端的明显麻木感，迫使病人止步，休息片刻后疼痛缓解，周而复始

④病情严重程度可用Rutherford分级

1级：轻度间歇性跛行、最大跛行距离＞500m

2级：中度间歇性跛行、最大跛行距离300-500m（2+3=5）

3级：重度间歇性跛行、最大跛行距离＜300m

4级：静息痛、夜间痛（静夜思）

5级：少量组织缺损或活动性溃疡

6级：大面积组织溃疡或坏疽

2.区别

动脉硬化闭塞症	血栓闭塞性脉管炎/Buerger病
累及中大动脉（可有血管杂音）	累及中小动静脉
＞45岁男性多见	青壮年男性多见
高血脂、高血压、糖尿病、吸烟等	吸烟（爱吸烟的小伙子）
广泛狭窄、钙化	节段性，游走性浅静脉炎

二、静脉性疾病

外科　周围血管疾病&泌外感染和肿瘤
00:19:27--00:32:23

1.共性

①表现：肿胀、暗红、潮热、下肢浅静脉如大隐静脉迂曲扩张

②治疗：抬高患肢（动低静高）、弹力袜或绷带、抗板、抗凝、扩管等

「理顺知识点」

- 抬高患肢、弹力袜或绷带→促进静脉回流

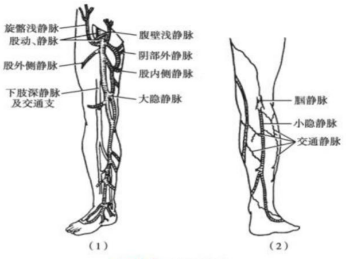


图 34-6　下肢浅静脉
（1）大隐静脉及其属支　（2）小隐静脉及其属支

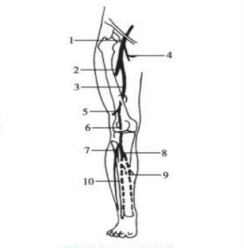


图 34-7　下肢深静脉
1. 股总静脉　2. 股深静脉　3. 股浅静脉
4. 大隐静脉　5. 小隐静脉　6. 胭静脉
7. 胫前静脉　8. 胫腓干静脉　9. 胫后静脉
10. 腓静脉

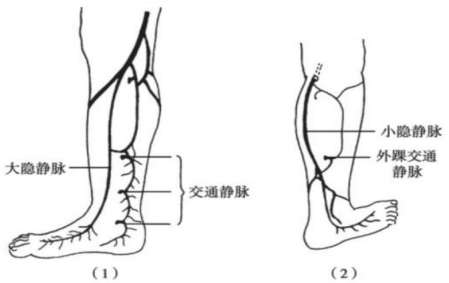
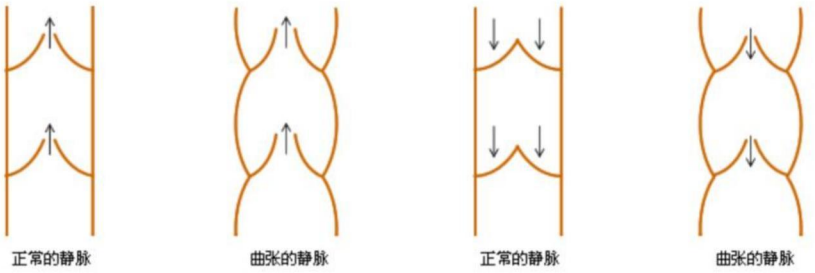
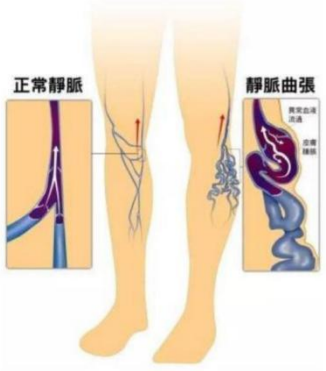


图 34-8　小腿浅静脉和交通静脉
（1）大隐静脉及内踝交通静脉　（2）小隐静脉及外踝交通静脉





2.持久站立、久坐、体力强度高等所致原发性/单纯性下肢静脉曲张

①机制：静脉瓣膜缺陷（静脉逆流）、静脉壁软薄、浅静脉压升高

②表现：早期浅静脉迂曲扩张，后期足靴区（小腿远侧1/3）色素沉着

③治疗：浅静脉结扎、曲张静脉剥脱、或向曲张静脉注射硬化剂

「理顺知识点」

- 静脉瓣膜缺陷→静脉逆流→浅静脉压升高
- 静脉壁本身软薄，平滑肌少，动脉平滑肌较多→静脉本身比动脉更容易发生曲张

3.下肢深静脉血栓形成（静脉回流障碍）

①机制：静脉损伤（胶原暴露）、血流缓慢（如长期制动）、血液高凝（如创伤/肿瘤）

②最严重：肺栓塞（没形成则动、形成后别动）

③治疗：经导管直接溶栓（VS内科）

「理顺知识点」

- 下肢深静脉血栓脱落→栓子随血液循环堵塞肺→突发肺栓塞
- 没形成则动、形成后别动：
  - 长期制动→血流缓慢→血栓形成风险↑→血栓未形成时鼓励活动
  - 已形成血栓后，突然活动会导致血栓脱落，严重时可引起肺栓塞→已形成血栓时建议休息

④类型：

周围型	局限在股静脉→大腿痛肿；局限在小腿深静脉→小腿痛肿、Homans征
中央型	髂窝、股三角区痛、全下肢肿
混合型	各处都痛+全下肢肿 股白肿（苍白、皮温升高），股青肿（青紫、动脉搏动消失、皮温下降）

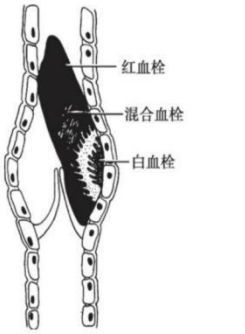


图 34-11　一个典型血栓形成的病理解剖

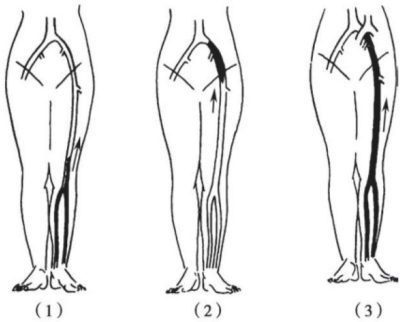


图 34-12　下肢深静脉血栓形成的类型
（1）周围型　（2）中央型　（3）混合型

三、检查

外科　周围血管疾病&泌外感染和肿瘤
00:32:23——00:35:32

1.首选超声多普勒，金标准血管造影



图 34-2　右髂总动脉栓塞
对比剂在栓塞近端骤然中断。

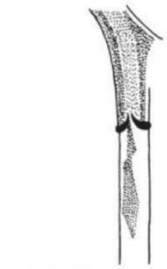


图 34-10　下肢静脉逆行造影
深静脉瓣膜功能不全时，显示对比剂自瓣膜近端向远端反流。





2.试验

Buerger （体位性色泽改变试验）	①动脉供血不足：主要是动脉硬化闭塞症、血栓闭塞性脉管炎 ②静脉逆流或回流障碍	B-闭塞
Trendelenburg	大隐静脉瓣膜功能不全	英文单词最长对应人体最长的浅静脉大隐静脉
Pratt	交通静脉瓣膜功能不全	tt-交替
Perthes	深静脉阻塞如血栓（Perthes阳性——禁止结扎、剥脱、或向曲张浅静脉注射硬化剂）	person
Homans （踝关节过度背伸试验Huai）	小腿深静脉血栓	男神的小腿

真题解析·周围血管疾病

外科　周围血管疾病&泌外感染和肿瘤
00:43:20--00:45:29

1.2015N78A女性，60岁。右下肢内侧静脉迂曲10年，伴酸胀。查体：Pratt试验阳性，临床意义是

A.下肢深静脉血栓形成

B.隐-股静脉瓣膜功能不全

C.交通支瓣膜功能不全

D.原发性下肢深静脉瓣膜功能不全

2.2019N64A判断大隐静脉曲张能否手术的关键检查是

A.Pratt试验

B.Trendelenburg试验

C.Perthes试验

D.Buerger试验

3.2021N98-99A男性，65岁。8日前行结肠癌根治术，2天来发热伴左下肢疼痛。查体：T38℃,腹部切口愈合良好，已拆线。左小腿肿胀，腓肠肌压痛(+)，Homans征(+)。检查：胸片正常，腹部B超示胸腔无积液，化验血WBC9.8×10^9/L，尿常规正常。

98.最可能的诊断是

A.左下肢肌筋膜炎

B.左下肢丹毒

C.左下肢深静脉血栓形成

D.左下肢浅静脉炎

99.下列治疗措施中错误的是

A.多做下肢运动

B.抬高患肢

C.抗凝

D.手术

　答案：1-3 C C CA